

DOI: 10.19538/j.nk2019050110

2018年嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范 专家共识解读



扫一扫下载指南原文

林燕凤, 张英秀, 付朝丽, 林梅顺, 陈嘉美, 张北平, 刘添文

摘要: 2018年由广州呼吸健康研究院牵头,联合国内外多学科专家制定了我国首个嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范专家共识(简称2018共识),2018共识首次提出局限型嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA)概念,为EGPA的早期诊治提供依据。根据受累器官不同,2018共识首次提出局限型EGPA概念,为EGPA的早期诊断及治疗提供依据。EGPA患者的预后与最初治疗方案相关。EGPA的治疗取决于疾病的严重程度、受累的器官、病情是否活动等因素。总体治疗方案分为诱导缓解和维持治疗2个阶段。诱导缓解治疗方案主要包括激素和(或)免疫抑制剂(如环磷酰胺);病情达到缓解后,维持治疗推荐使用硫唑嘌呤或甲氨蝶呤,2015年全球EGPA诊治专家共识推荐的治疗时间为疾病达到缓解后至少24个月。2018共识结合当今国际最新进展,介绍了生物靶向治疗药物在EGPA的应用。

关键词: 嗜酸性肉芽肿性多血管炎;激素;免疫抑制剂

中图分类号: R593 **文献标识码:** A

Interpretation of expert consensus on diagnosis and treatment of eosinophilic granulomatous polyvasculitis in 2018. LIN Yan-feng, ZHANG Ying-xiu, FU Chao-li, LIN Mei-shun, CHEN Jia-mei, ZHANG Bei-ping, LIU Tian-wen. First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou Institute of Respiratory Health, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, State Key Laboratory Disease, Guangzhou 510120, China

Corresponding author: ZHANG Qing-ling, E-mail: zqling68@hotmail.com

Abstract: According to the different organs involved in patients, the concept of localized Eosinophilic granulomatous polyvasculitis (EGPA) was first proposed by consensus in 2018, which provides a basis for the early diagnosis and treatment of EGPA. The prognosis of patients with EGPA is related to the initial treatment. The treatment of EGPA depends on the severity of the disease, the organs involved and whether the disease is active or not. The overall treatment plan is divided into two stages: induction remission and maintenance therapy. Induced remission therapy mainly includes hormones and/or immunosuppressive agents (e.g. cyclophosphamide). After remission, azathioprine or methotrexate is recommended for maintenance therapy. In 2015, the global consensus of EGPA diagnostic and therapeutic experts recommended that the duration of treatment should be at least 24 months after remission. In combination with the latest international progress, the first Expert Consensus on Diagnosis and Treatment of EGPA in China 2018 consensus introduced the application of Bio-Targeting drugs in EGPA.

Keywords: eosinophilic granulomatous polyvasculitis; hormone; immunosuppressive agents



张清玲,广州呼吸健康研究院、呼吸疾病国家重点实验室医学博士,呼吸内科主任医师、教授,广州医科大学硕士生导师。呼吸疾病国家重点实验室项目负责人(PI)。兼任中华医学会呼吸病学分会第十届哮喘学组委员,中国医师协会呼吸医师分会哮喘与变态反应工作委员会委员,中华医学会海峡两岸医药卫生交流协会呼吸病学专业委员会委员,广东省医师协会呼吸科医师分会常务委员。

作者单位: 广州医科大学附属第一医院 广州呼吸健康研究院
国家呼吸系统疾病临床医学研究中心/呼吸疾病国家重点实验室,
广东广州 510120

通信作者: 张清玲, 电子信箱: zqling68@hotmail.com

嗜酸性肉芽肿性多血管炎(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)是一种可累及全身多个系统的、少见的自身免疫性疾病,主要表现为外周血及组织中嗜酸粒细胞(EOS)增多、浸润及中小血管的坏死性肉芽肿性炎症,属于抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)相关性系统性血管炎。但与其他血管炎不同,EGPA最早且最易累及呼吸道和肺,绝大多数首发表现为喘息样发作和鼻-鼻窦炎症状,因此首诊于呼吸内科,常被误诊为难治性哮喘。随着病情进展,全身多系统均可受累并造成不可逆的器官损害。

由于我国缺乏EGPA大样本的临床数据和资

料,不同学科对 EGPA 的描述与诊治存在差异^[1]。为进一步提高我国各学科对该病的系统认识及临床诊疗水平,由广州呼吸健康研究院钟南山院士、陈荣昌院长及中山大学附属第三医院风湿科古洁若教授牵头,广州呼吸健康研究院张清玲教授执笔,广泛征求国内外多学科专家的意见,同时参考国内外近年来 EGPA 的研究成果与诊治经验,制定了我国首个嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范多学科专家共识(以下简称 2018 共识)^[2]。

1 EGPA 的临床表现

EGPA 可累及鼻窦、肺、皮肤、神经系统、心脏、胃肠道、肾脏等多个器官,其中绝大多数患者存在哮喘和(或)变应性鼻炎。目前认为,EGPA 的发病机制为 ANCA 介导的血管壁损伤和 EOS 浸润。ANCA 介导的 EGPA 以肾脏受累为主,还可出现紫癜、肺泡出血、鼻窦炎等,周围神经病变的发生率较高;而 EOS 浸润介导的 EGPA 以肺部受累为主,心脏受累(如心包炎和心肌病)、胸腔积液和发热的发生率更高。EGPA 自然病程可分为前驱期、组织 EOS 浸润期和血管炎期,但不是所有 EGPA 患者均会经历 3 个分期,且分期没有明显的界限,可同时出现喘息、EOS 浸润和血管炎的表现。

EGPA 前驱期除出现一般症状如发热、全身不适外,常出现多种呼吸道疾病症状,96%~100% 的患者可出现喘息、咳嗽、呼吸困难等,与单纯哮喘难以鉴别。大部分患者有多组鼻窦受累,少部分患者可累及眼眶,极少数患者可出现鼻腔或鼻窦肉芽肿、出血及鼻腔结痂等肉芽肿性血管炎改变,还可出现分泌性中耳炎及神经性耳聋等。因此,大部分 EGPA 患者最早在呼吸专科门诊就诊,并常被误诊为难治性 EOS 性哮喘。组织 EOS 浸润期常表现为外周血 EOS 增多及器官浸润(包括肺、心肌、胃肠道等),60%~70% 的患者出现肺部受累。组织 EOS 浸润期可持续数月或数年,有些患者亦可出现在血管炎期。血管炎期常表现为严重的喘息、呼吸困难及系统性(坏死性)血管炎引起的一系列继发性改变,如发热、咯血、皮肤损害、心功能不全、肾功能不全及神经系统损伤等。

2 病史与辅助检查

需要仔细询问病史并进行体检,及早发现 EGPA 可疑病例。外周血 EOS 增多(常>10%)

是 EGPA 的特征之一,可出现于病程的任何阶段。2018 共识特别提出要注意的是长期口服激素(包括含有激素的中药复方)可影响外周血 EOS 的实际水平。仔细询问病史,尤其是了解发病时或治疗前的血 EOS 比例,有助于早期发现 EGPA。此外,诱导痰或支气管肺泡灌洗液(BALF)中 EOS 明显增高也是重要特征之一,EGPA 患者 BALF 中 EOS 的比例可高达 25% 以上。ANCA 的检测必须同时采用间接免疫荧光法(IIF)和酶联免疫吸附测定法(ELISA)两种方法。ANCA 阴性时不能排除 EGPA 的可能性。ANCA 阳性患者出现发热及肾脏受累的发生率高,胸部影像学出现较多的肺部蜂窝影样改变,而 ANCA 阴性患者的通气功能明显下降。血清 IgE 和 IgG 水平升高,为 EGPA 的特征之一,但需与其他 IgE 和 IgG 水平升高的疾病相鉴别,如变应性支气管肺曲霉病(ABPA)、恶性肿瘤及其他结缔组织病等。血 IgE 和 IgG 水平与 EGPA 病情相关,血管炎反复发作时,血 IgE 和 IgG 可持续升高,EGPA 病情缓解时下降。此外,EGPA 前驱期变应原特异性 IgE(specific IgE,slgE)可以增高。此外,重视尿常规的检查,可及早发现是疾病累积肾的表现。

影像学检查:鼻窦 CT 检查可发现鼻窦炎的表現。肺部影像学表现为多变的游走性病变,激素治疗后短时间内变化明显。常见的影像学异常包括广泛的支气管壁增厚、斑片状磨玻璃影和肺纹理增粗,还可出现多发小叶中心结节、树芽征、小结节、空气潴留、支气管痰栓、肺气肿、实变灶、支气管扩张、肺小血管纹理增粗、肺不张、肺间质性改变、纵隔淋巴结肿大、胸腔积液及胸膜增厚等,这些肺部影像学表现是 EGPA 与难治性哮喘鉴别的重要依据之一。

组织病理学检查:病理学检查对 EGPA 的诊断非常有帮助。EGPA 病变可以累及肺脏、心脏、肾、皮肤、胃肠道、淋巴结、胰腺、脾等,典型表现为肉芽肿和坏死性病变,坏死灶内可见 EOS、嗜酸性坏死碎片、夏科-雷登结晶,周围有类上皮细胞和多核巨细胞形成的肉芽肿。肺受累的 EGPA,经纤维支气管镜肺活检(TBLB)病理发现典型坏死性肉芽肿性病变的阳性率不高,电视胸腔镜手术(VATS)肺活检的临床价值要大于 TBLB,但由于是有创性检查,需要十分慎重。

3 诊断

目前 EGPA 的诊断标准主要参考 1990 年美国

风湿病学会提出的分类标准(表1)。2018共识特别提出,该标准中的第1条“哮喘”的真正含义是指哮喘样表现,包括喘息、咳嗽、胸闷及呼吸困难等。EGPA一旦确诊,需详细评估呼吸系统、肾、心脏、胃肠道和(或)外周神经等多器官受累情况。

表1 1990年美国风湿病学会嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA)分类标准

标准	定义
“哮喘” ¹⁾	喘息病史或呼气相弥漫高调的啰音
外周血嗜酸粒细胞(EOS)增多	>10%
单发或多发神经病变	由系统血管炎引发的单神经或多发性单神经病变或多神经病变(手套/袖套样分布)
肺非固定性浸润影	影像学检查提示游走性或短暂性肺部浸润影(不包括固定性浸润影)
鼻窦病变	鼻窦疼痛或压痛,鼻窦影像学提示鼻窦透亮度下降
活检提示血管外EOS浸润	活检结果(包括动脉、小动脉、小静脉)显示血管外大量EOS浸润

注:1)指的是哮喘样表现,包括喘息及呼气相弥漫高调的啰音等

2018共识广泛征求国内外多学科专家意见,同时参考了国内外近年来EGPA的研究成果及诊治经验,提出了EGPA可分为局限型和全身型两种。满足1990年美国风湿病学会制定的6条标准中的至少4条,且仅有肺部和呼吸系统受累(包括耳鼻喉)的EGPA患者,称为局限型EGPA。若满足1990年美国风湿病学会制定的6条标准中的至少4条,有至少2个及以上器官受累者,则为全身型EGPA。局限型EGPA可以转化为全身型EGPA。

4 治疗

EGPA的治疗取决于疾病的严重程度、受累的器官、病情是否活动等因素。2018共识参照全球最新的EGPA诊治专家共识2015年版中的22条推荐标准,活动期全身型EGPA定义为新出现或复发或恶化的EGPA[不包括哮喘和(或)耳鼻喉部表现],需要添加或增加激素用量和(或)添加或更换

其他免疫抑制剂。2018共识参照我国支气管哮喘防治指南2016年版,活动期局限型EGPA的定义为喘息、咳嗽、胸闷等症状加重,并伴有呼气峰流速下降和(或)外周血EOS升高。

EGPA患者的预后与最初治疗方案相关。制定治疗方案前要先进行5因子评分以评估是否存在预后不良的因素。目前评估预后的标准主要参考2011年修订的5因子评分评价体系。5因子评分:0分:EGPA患者可使用激素控制症状; ≥ 1 分:建议激素和免疫抑制剂联合治疗。总体治疗方案分为诱导缓解和维持治疗2个阶段。缓解的定义为临床表现[除哮喘和(或)耳鼻喉部表现]消失。诱导缓解治疗方案主要包括激素和(或)免疫抑制剂(如环磷酰胺),诱导缓解治疗的疗程目前尚无定论;病情达到缓解后,维持治疗推荐使用硫唑嘌呤或甲氨蝶呤,维持治疗疗程尚无定论,2015年全球EGPA诊治专家共识推荐的治疗时间为疾病达到缓解后至少24个月。2018共识结合当今国际最新进展,介绍了生物靶向治疗药物在EGPA的应用。

总体来说,目前国内外对于EGPA的认识不足,如发病机制、病理改变、基因组学、疾病表型的特点及环境影响等,2018共识第一次提出了局限型EGPA,对EGPA的早期诊断及治疗提供依据,早期发现EGPA患者,是EGPA早期诊断、规范治疗、提高疗效、降低疾病致残率和病死率的关键,有利于提高我国对EGPA的诊治。

参考文献

- [1] Bloch DA, Michel BA, Hunder GG, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of vasculitis. Patients and methods[J]. Arthritis Rheum, 1990, 33(8):1068-1073.
- [2] 嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范多学科专家共识编写组. 嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范多学科专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2018, 41(7): 514-521.
- [3] Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides[J]. Arthritis Rheum, 2013, 65(1): 1-11.

2019-03-11收稿 本文编辑: 张建军